

Partizipative Entscheidungsfindung

Kommunikation

Informationen teilen, gemeinsam entscheiden

Gunnar Geuter

Lerneinheit

Der informierte Patient



Zusammenfassung

Wer bei der Behandlung mitentscheiden kann, wird schneller gesund – so lautet die Kernbotschaft der Partizipativen Entscheidungsfindung (PEF). In dieser Strategie steckt die Hoffnung, Geld und Zeit zu sparen, aber auch die Lebensqualität der Patienten zu erhöhen.

Die medizinische, therapeutische und pflegerische Versorgung geht (nicht nur) in Deutschland allzu oft über die Köpfe der Patienten hinweg. Ärzte, Therapeuten und Pflegende treffen Entscheidungen, ohne Patienten Alternativen aufzuzeigen. Sie berücksichtigen dabei nicht die individuellen Ressourcen, Werte und Bedürfnisse des Patienten und dessen Körper-Kompetenz. Die Folge: Missverständnisse entstehen, und die Interaktion zwischen Ärzten, Therapeuten, Pflegenden und Patienten misslingt. Das kann wiederum zu folgenschweren therapeutischen Fehlentscheidungen führen und mündet in letzter Konsequenz in eine Unter-, Über- oder Fehlversorgung. Zudem geht die Therapie häufig an den Bedürfnissen der Patienten vorbei, wodurch diese nicht bereit sind, aktiv mitzuarbeiten – die Behandlung/Pflege ist ineffektiv und ineffizient (Scheibler et al 2005).

Patienten wünschen Partnerschaft

Viele Patienten wollen Therapieentscheidungen gemeinsam mit dem Arzt treffen. Das zeigen Studien zur Patienten-Arzt-Interaktion. So wünscht sich in Deutschland eine deutliche Mehrheit der Patienten einen partnerschaftlichen Entscheidungsstil (Klemperer 2005). Doch leider herrscht nach Ansicht der Befragten ein asymmetrischer, vom Arzt dominierter Interaktionsstil (Scheibler et al 2003).

Vorreiter USA und Großbritannien. Anders sieht es in den englischsprachigen Ländern aus. Dort wurde in den 1970er Jahren die Partizipative Entscheidungsfindung (PEF; *engl. shared decision-making*) etabliert, die Ärzte mehr und mehr flächendeckend umsetzen (ebd.). In Deutschland wird die PEF erst seit ein paar Jahren breiter diskutiert, bislang vor allem in der Medizin. Dieses Interaktionsmodell sieht den Patienten als gleichberechtigten Partner im therapeutischen Prozess und bezieht ihn aktiv in alle therapierelevanten Entscheidungen ein. Es beruht auf den Grundsätzen einer geteilten Informationsweitergabe und einer gleichberechtigten und gemeinsam verantworteten Entscheidungsfindung bezüglich Diagnose und Therapie (ebd.). Die PEF ist charakterisiert durch:

- die Partizipation beider Teilnehmer (z.B. Pflege und Patient) am Prozess der Entscheidungsfindung,
- die gegenseitige Bereitstellung von Informationen und
- das Einverständnis beider Teilnehmer hinsichtlich der getroffenen Behandlungsentscheidung und die Bereitschaft, diese aktiv und in geteilter Verantwortung umzusetzen (Charles 1997).

Interaktion ist symmetrisch

In Abgrenzung zu anderen Interaktionsmodellen ist die Interaktion zwischen Pflege und Patient im Rahmen der PEF symmetrisch: Als Experte steuert der Therapeut evidenzbasierte fachliche Informationen bei, der Patient seine Werte, Einstellungen, Wünsche und Ressourcen. Die subjektive Seite des Patienten sollte unbedingt Teil der Entscheidungsfindung werden, um zu einer Lösung zu kommen, die an ihm ausgerichtet ist (Klemperer 2003). Die PEF kann als Interaktionsstil hinsichtlich des Patientenverhaltens der sogenannten *Adherence* zugeordnet werden (s. hierzu ausführlicher den vorigen Beitrag von Michael Schulz in dieser Lerneinheit). Sie ist ein modernes Interaktionsmodell, das Patientenautonomie und -souveränität (also *Empowerment*) fördert und fordert.

Tab. 1 Partizipative Entscheidungsfindung eingeordnet in Modelle der Pflege-Patienten-Interaktion. (Grad der Patientenautonomie von niedrig nach hoch)

Interaktionsmodell	Paternalistic model	Partizipative Entscheidungsfindung (PEF)	Informed decision making model
Wer entscheidet?	Pflege bevormundet Patienten	Pflege und Patient treffen als Partner gemeinsam Entscheidungen	Pflege ist Informationsgeber und setzt gewünschte Intervention um; Patient handelt.
Wer kontrolliert Informationen?	Pflege hat alleinige Kontrolle	Pflege und Patient haben gemeinsam die Kontrolle	Beide haben Kontrolle über Infos. Die Kontrolle über die Entscheidung obliegt allein dem Patienten.
Patientenwünsche, Werte, Einstellungen?	Werden nicht in die Entscheidung einbezogen	Werden in vollem Umfang in die Entscheidung einbezogen	Werden in vollem Umfang in die Entscheidung einbezogen.

Nicht für jeden Patienten sinnvoll

Von der patientenzentrierten Interaktion (*patient centredness*) grenzt sich die PEF insofern ab, als dass bei Ersterer zwar Pflege und Patient die Informationen teilen, allerdings die Pflege die Entscheidungen alleine trifft (Scheibler et al 2003). Dies kann bei Patienten in schwierigen Situationen, in denen sie nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu fällen, sinnvoll sein. Die PEF ist also nicht die einzig wahre Interaktionsform. Interaktionsform und Versorgung des Patienten sollten abhängig von seiner Persönlichkeit, seiner Lebenssituation und Bedürfnissen gewählt werden.

Erhöht Zufriedenheit chronisch Kranker. Die PEF scheint besonders bei Patienten mit chronischen Krankheiten sinnvoll zu sein. Die Patienten haben über längere Zeit Kontakt mit Ärzten, Therapeuten und der Pflege und entwickeln sich mehr und mehr zum Experten: Sie wissen über ihre Krankheit und ihren Körper oft bestens Bescheid. Dadurch entwickeln sie häufig ein starkes Bedürfnis, die Therapieentscheidung zu beeinflussen. Die PEF ist zudem bei Interventionen geeignet, bei denen mehrere Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen (ebd.). Ihr wird in Zukunft eine immer größere Bedeutung zukommen, da aufgrund der demografischen Entwicklung chronische Erkrankungen häufiger werden und sich die Therapiemöglichkeiten durch zunehmende Differenzierung vergrößern. Auch deshalb hat das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) 2001 einen Förderschwerpunkt „Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess“ gegründet (www.patient-als-partner.de). Er soll u. a. die deutsche Forschung zum Thema PEF fördern.

Studien belegen positive Effekte

Studienergebnisse aus anderen Ländern zeigen, dass der Patient in vielerlei Hinsicht profitiert, wenn er selbst über seine Therapie entscheiden darf. Er ist zufriedener, motivierter und wird schneller gesund. Die Studien beziehen sich nahezu ausschließlich auf die Arzt-Patienten-Interaktion, doch es ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnisse zu weiten Teilen auf den pflegerischen Entscheidungsfindungsprozess übertragen lassen (ebd.).

Pflegende und Patient gefordert

Für eine erfolgreiche Umsetzung sollten **Pflegende** ihre Fähigkeiten der Kommunikation ausbauen und über Modelle von Gesundheit und Krankheit sowie über unterschiedliche Interaktionsmodelle Bescheid wissen und diese situativ und auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt anwenden können. Sie benötigen die Fähigkeit der kritischen Selbstreflexion und die Bereitschaft, Entscheidungen tatsächlich partnerschaftlich mit dem Patienten zu treffen. Außerdem sollten sie bereit sein, den Patienten Mut zu machen, sich aktiv einzubringen und wichtige Informationen und Entscheidungen zu teilen.

Der **Patient** hingegen muss die Bereitschaft mitbringen, sich am Entscheidungsfindungsprozess aktiv beteiligen zu wollen und Verantwortung für die Entscheidung zu übernehmen. Will er das nicht, obwohl die Pflege ihm die Vorteile aufgezeigt hat, scheint die PEF nicht die richtige Interaktionsform für ihn zu sein. Souveräne Patienten hingegen wollen mitentscheiden. Sie werden von den Akteuren im Gesundheitssystem leider immer noch allzu oft als „Störgröße“ betrachtet. Auf der anderen Seite können viele Patienten dominanten Ärzten, Therapeuten und Pflegenden nichts entgegensetzen, da sie kaum über ihre Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten informiert sind (Scheibler et al 2003).

PEF hat Zukunft

PEF erfordert persönliches Engagement und den Mut, neue Wege im Umgang mit dem Patienten zu beschreiten. Es hängt in erster Linie von der Grundeinstellung, dem Rollenverständnis und der Bereitschaft des einzelnen Therapeuten oder der Pflegeeinrichtung ab, ob die PEF zum festen Bestandteil der Versorgung wird. Die nachgewiesenen Erfolge der PEF und die positiven Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Patienten und Behandelnden dürften Grund genug sein, sich auf den Weg zu machen.

Mehr zum Thema

Wie Sie Patienten optimal auf den Alltag vorbereiten, zeigt Ihnen außerdem auch die Lerneinheit Patienten informieren, schulen und beraten.

Vita

Gunnar Geuter ist Physiotherapeut, Diplomb Berufspädagoge (FH) und Gesundheitswissenschaftler an der Universität Bielefeld

Literatur

1 Scheibler F , Schwantes U , Kampmann M . et al. Shared decision-making. Wissenschaftsforum in Gesundheit und Gesellschaft 2005; 5: (1) 23-31

2 Klemperer D , Partizipative Entscheidungsfindung in Deutschland – Handlungsfelder zur Verbesserung der Entscheidungsqualität. In: Härter M , Loh A , Spies C . Hrsg. Gemeinsam entscheiden – erfolgreich behandeln. Neue Wege für Ärzte und Patienten im Gesundheitswesen Köln: Deutscher Ärzte-Verlag 2005; 25-44

3 Scheibler F , Pfaff H , Shared decisionmaking. Ein Konzept der Professionellen Patienten-Interaktion. In: Scheibler F , Pfaff H . Hrsg. Shared Decision-Making. Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess Weinheim und München: Juventa 2003; 11-22